

Gynækologiske sygdomme & obstetrik

KØBENHAVNS UNIVERSITET



Kursus i Sygdomslære
Louise Heimdal Nilsson

Studiecaféerne i sygdomslære

1+2:	Bevægeapparatets sygdomme + intro
3+4:	Neurologiske sygdomme
7+8:	Endokrine sygdomme
5+6:	Psykiske sygdomme
9+10:	Hjerte-kar-sygdomme
11+12:	Blodsygdomme
13+14:	Lungesygdomme
15+16:	Allergiske sygdomme
17+18:	Mave-tarm-sygdomme
19+20:	Nyre- og urinvejssygdomme
21+22:	Gynækologiske sygdomme og obstetrik
23+24:	Infektionssygdomme
25+26:	Kræftsygdomme

Pensum

Else Marie Bladbjerg & Jens Brings Jacobsen

Sygdomslære for ikke-klinikere

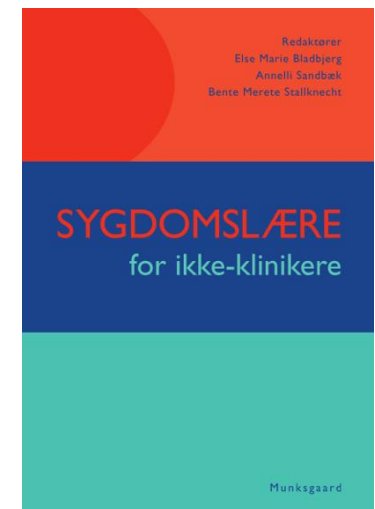
2. udgave, Munksgaard

Obs! Hele lærebogen er pensum

+ et kompendium i mikrobiologi (Absalon)

Dagens pensum:

- Kapitel 13 – Gynækologiske sygdomme og obstetrik (s. 389-414)
 - Med en helt del undtagelser



Gynækologiske sygdomme og obstetrik

- Det fysiologiske blødningsmønster
- Amenoré (manglende menstruation) og oligomenoré (sjældne menstruationer)
- Menoragi (kraftige menstruationer)
- Metroragi (uregelmæssige blødninger)
- Postmenopausal blødning
- Polycystisk ovariesyndrom (PCOS)
- Cervikal intraepitelial neoplas, CIN (celleforandringer på livmoderhalsen)
- Benigne ovariecyster og -tumorer
- Infertilitet
- Spontan abort
- Ekstrauterin graviditet
- Svangreprofylakse
- Prænatal diagnostik
- Præterm fødsel
- Væksthæmning af fosteret
- Præeklampsi (svangerskabsforgiftning)

Dagsorden



Gyn-obs sygdomme generelt



Kort om kvindens anatomi



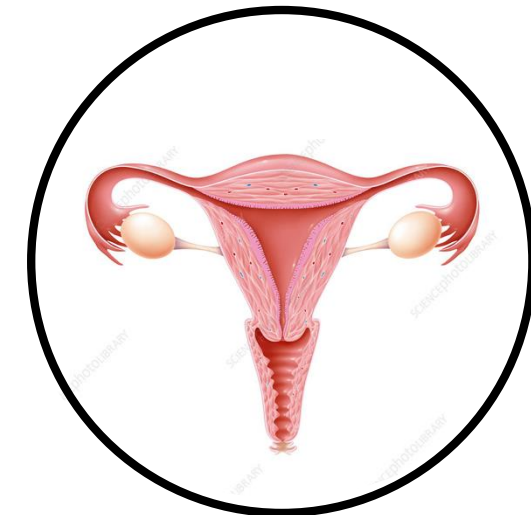
PCOS



Cervical intraepitelial neoplasi (CIN)



Eksamensopgaver



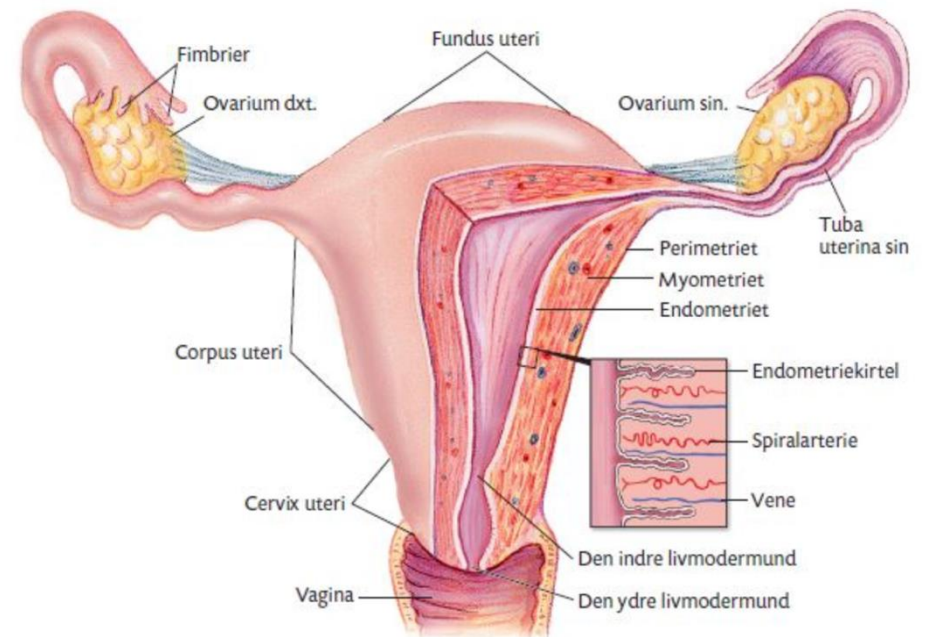
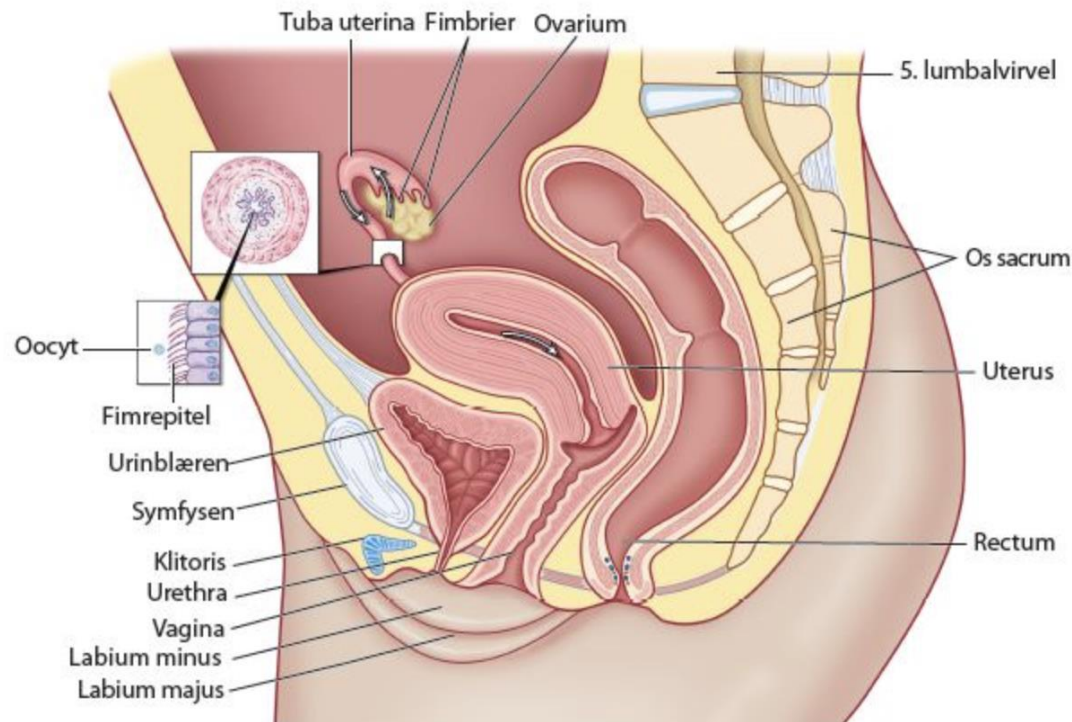
Gynækologi

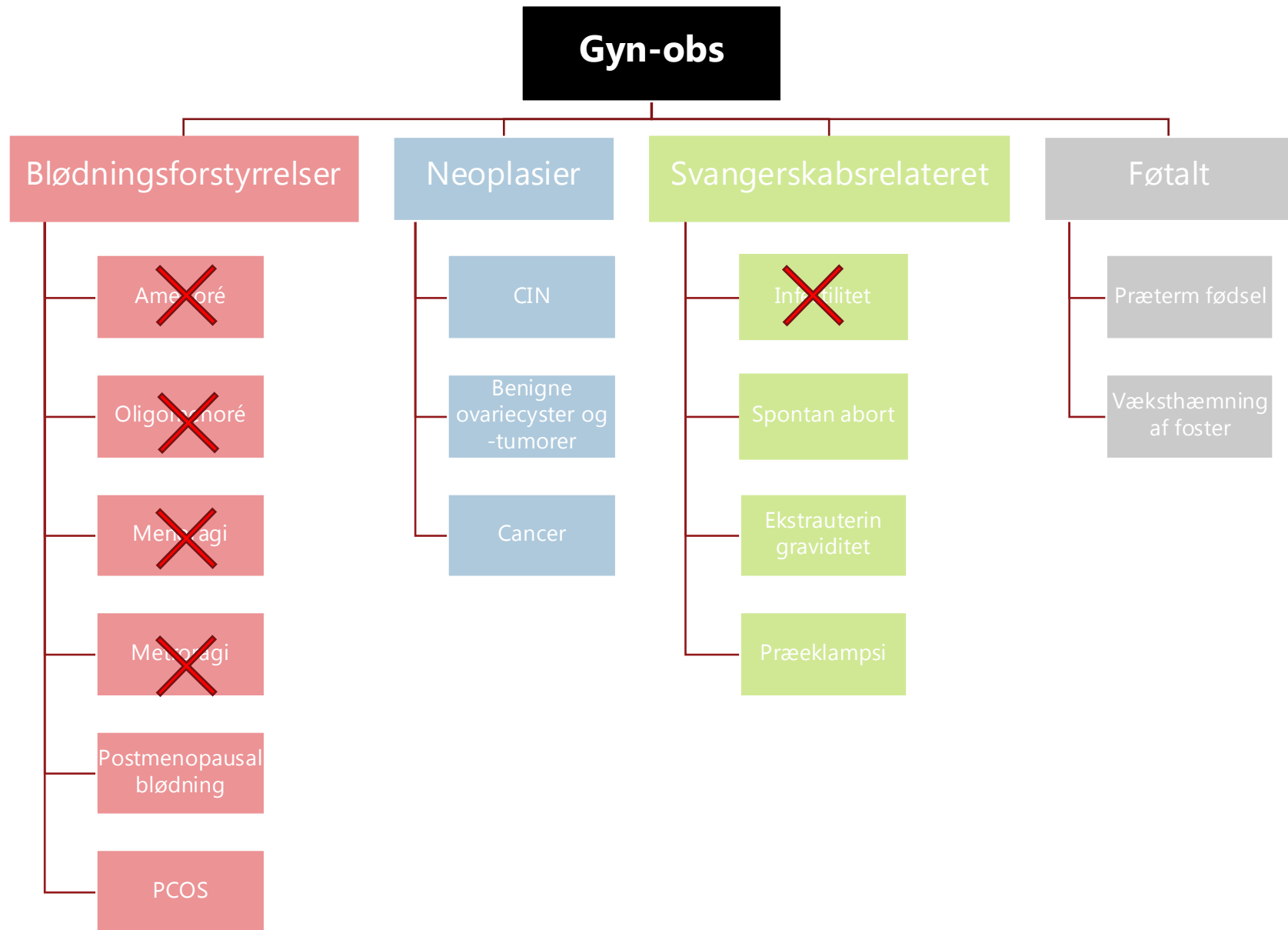
- Sygdomme og symptomer i de kvindelige kønsorganer
 - Forebyggelse
 - Udredning
 - Behandling
- Genitalia externa, vagina, uterus, tuba uterina, ovarier

Obstetrik

- Svangreprofylakse
- Prænatal diagnostik
- Fødselshjælp

Oversigt over kvindens anatomi





Opgave 1

PCOS

- Definér PCOS
- Redegør for patogenese og ætiologi for PCOS
- Beskriv kort symptomer og fund for PCOS
- Redegør kort for diagnostikken af PCOS

Polycystisk ovariesyndrom (PCOS)

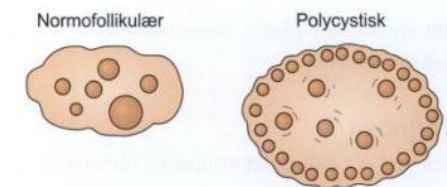
Definition:

Tilstand, hvor to ud af tre kriterier er opfyldt

- 1) Øget produktion af androgener (mandlige kønshormoner) eller hirsutisme (øget hårvækst)
- 2) Blødningsforstyrrelser i form af
 - Oligomenoré (sjældne blødninger, cyklus over 35 dage) eller
 - Amenoré (manglende blødning i min. 6 måneder)
- 3) Polycystiske ovarier
 - Ovariet indeholder mange små, umodne follikler på 4-7mm størrelse (cyster), der ikke videreudvikles
 - Ligger typisk som perler på snor i kanten af ovarierne
 - Kan påvises hos 20% af yngre kvinder, men mange er raske og normal ovulation

Patogenese:

- Perifer insulinresistens → øget insulinproduktion
- Insulin → øget LH-produktion fra hypofyse
- Øget Insulin + LH → øget androgenproduktion i ovarier (og binyrer) + nedsat produktion af SHGB (insulin)
 - SHGB = sex hormon binding globulin, lavt niveau → øget andel af frie metabolisk aktive androgener
- Forhøjet androgenkoncentration → hæmmet follikelmodning i ovarie + hæmmet ovulation → hæmmet cyklisk forandring af endometriet (+ øget mandlig hårvækst)



Figur 13.1. Et normofollikulært ovarium (normalt ovarium) og et polycystisk ovarium hos en patient med PCOS.

Polycystisk ovariesyndrom (PCOS)

Ætiologi

- Familiær disposition
- Association til overvægt, diabetes og hjertekarsygdom
- Sværhedsgrad af symptomer kan påvirkes af livsstilsfaktorer – især overvægt

Symptomer og fund

- Hirsutisme (øget hårvækst med maskulint præg) – især hårvækst i ansigt og på brystet, maven og lænden
- Acne
- Overvægt
- Uregelmæssige og sjældne menstruationsblødninger

Polycystisk ovariesyndrom (PCOS)

Diagnostik

Transvaginal ultralydsscanning

- Tæt ovariestroma
- Mange små follikler (4-7 mm i diameter) placeret i kanten af ovarierne (randstillede)

Blodprøver

- LH/FSH-ratio over 1
- Forhøjede koncentrationer af androgener
- Lav koncentration af SHBG → øget mængde frit testosteron
- Øget waist-hip ratio
- Ofte højt BMI

Opgave 2

Cervical intraepitelial neoplasi (CIN)

- Definér CIN
- Redegør for patogenese og ætiologi for CIN

Cervical intraepitelial neoplasi (CIN)

Definition:

- Også kaldet "celleforandringer på livmoderhalsen"
- **Histologisk** diagnose (dvs. diagnose ud fra mikroskopisk vævsudseende)
- **Pladeepitelceller** på cervix: Fund af atypiske celler med store kerner og mange mitoser (**dysplasi**)
 - Potentielt **præmalign** tilstand (dvs. forstadie til cancer)
- CIN gradueres i tre sværhedsgrader (CIN I, CIN II, CIN III)
 - Ud fra, hvor stor en andel af epitellaget, der er inddraget (jo mere, jo højere sværhedsgrad og alvorlighed)
 - CIN III kan også omtales **carcinoma in situ (CIS)**, som er cancerforandringer, der endnu ikke har invaderet andet væv)

Patogenese:

- Transformationszone er særligt sårbart for ydre påvirkning, som kan forårsage celleforandringer, der kan videreudvikles til cancer
 - Transformationszone = overgangsområde mellem pladeepitel i cervix uteri/ectocervix og cylinderepitel i endocervix

Ætiologi:

- Skyldes infektion med HPV (human papilloma-virus)
 - Seksuelt overført sygdom
 - Over 200 typer af HPV, ca. 25 er onkogene for mennesker (potentielt kræftfremkaldende)
 - HPV type 16 og 18 forårsager ca. 70% af alle cervixcancer-tilfælde i DK
- Tobaksrygning er selvstændig risikofaktor

Opgave 3

Eksamensopgave sommer 2018 syge-reeksamen

Spontan abort

- Angiv definition
- Angiv risikoen for spontan abort, når en graviditet er erkendt (udebleven menstruation + positiv graviditetstest) samt i hvilket trimester spontan abort er hyppigst
- Angiv forhold hos foster og moder der disponerer til abort
- Beskriv kort for symptomer og fund
- Diagnostik: Angiv den væsentligste billeddannende teknik, som anvendes til at undersøge, om der er et levende foster i livmoderen
- Redegør for behandling og følgesygdomme

Spontan abort

Definition:

Graviditetstab før 22 svangerskabsuger (herefter er der tale om en fødsel)

Forekomst:

- 10-15% af alle erkendte graviditeter
- Hyppigst i 1. trimester (i 3. trimester vil det pr. definition være en fødsel)
- Hver 3. kvinde oplever en spontan abort
- Abortus habituais:
 - 3 eller flere aborter i træk
 - Ses hos ca. 1% af kvinder der forsøger at få børn

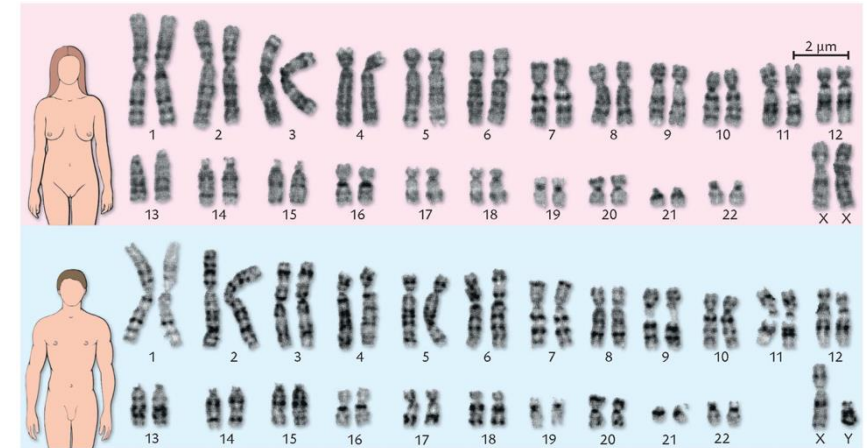


Spontan abort

Ætiologi/disponerende faktorer:

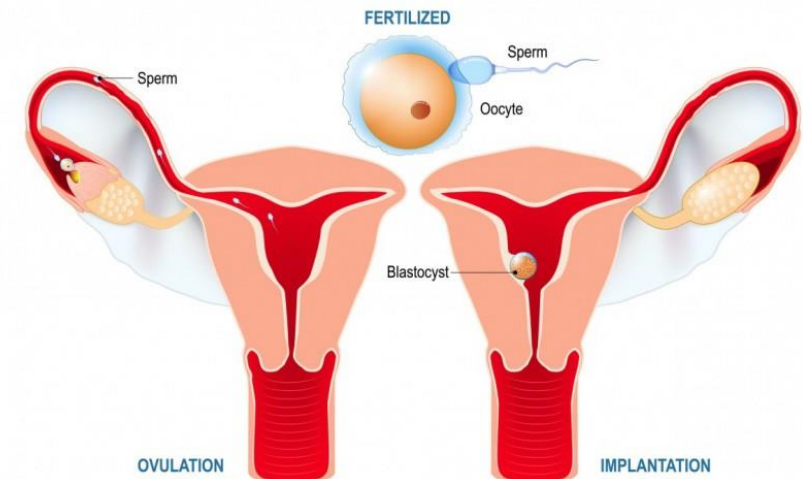
Hos foster:

- **Kromosomfejl** (findes i 60% af tilfældene)
 - Medfører mangelfuld implantation
 - Risiko stiger med kvindens alder (især over 35 år)
- Antages, at der endnu hyppigere er små kromosomforandringer



Hos moder:

- **Overvægt, diabetes, rygning**
- Sjældent (typisk ved abortus habituais)
 - Kromosomabnormiteter hos parret
 - Abnorm immunologi/anatomi/endokrinologi
- Obs! Det er ikke bevist, at fysisk træning, samleje og emotionelle faktorer fremkalder spontan abort



Spontan abort

Symptomer og fund:

I den tidlige graviditet (hvor spontan abort er hyppigst)

- Smerter
- Blødning

I den mere fremskredne graviditet

- Akut påvirkning
- Kraftig blødning
- Blodtryksfald

Symptomer kan også være så vage, at tilgründegået graviditet først opdages ifm. nakkefoldsscanningen (uge 11-14)



Spontan abort

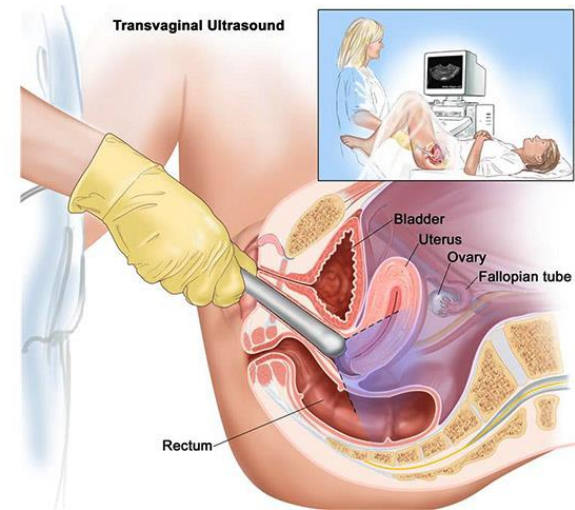
Diagnostik:

Gynækologisk undersøgelse + vaginal ultralydsscanning

- Er der et foster i livmoderen?
- Er der fosterhjerteraktion?

Målinger af hCG koncentration som monitorering

- hCG: human-chorio-gonadotropin (graviditetshormon)
- Kan måles i både blod og urin (positiv = gravid)
- Produceres af moderkagens celler og er vigtigt for opretholdelse af graviditeten
- Stiger dagligt indtil ca. uge 20
- Faldende? → Tabt graviditet



Spontan abort

Behandling:

Hvis moderen er upåvirket og foster er gået til grunde:

- Medicinsk behandling: **Prostaglandiner**
 - Peroralt (gennem mund) eller vaginalt (gennem skede)
 - Medfører sammentrækning af livmoderen → udstødning af graviditetsprodukt

Hvis moderen er akut påvirket / bløder kraftigt:

- **Akut udskrabning** for at rømme livmoderen for graviditetsvæv
 - Så kan den trække sig sammen igen og dermed standse blødningen

Ved abortus habituais kan enkelte af de underliggende årsager behandles

- Intrauterine polyper: Resektion
- Autoimmune forhold: Magnylbehandling

Følgesygdomme:

- Infektion (pga. inkomplet tømning af livmoderen og langvarig blødning)
- Skade på æggelederne (ved svær infektion)
- Psykisk krisereaktion

Opgave 4

Eksamensopgave sommer 2019 syge-reeksamen Ekstrauterin graviditet (graviditet uden for livmoderen)

- Angiv forekomst (hvor mange procent af alle graviditeter)
- Redegør for ætiologi og patogenese
- Beskriv kort symptomer og fund
- Beskriv kort principper for diagnostik og behandling

Ekstrauterin graviditet

Forekomst:

- Forekommer i 1-2% af alle graviditeter
- Hyppigere efter fertilitetsbehandling

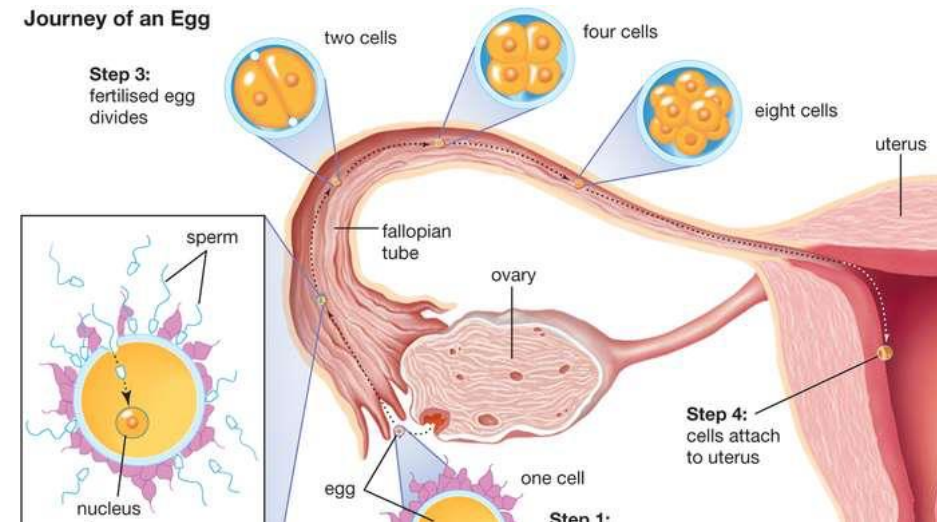
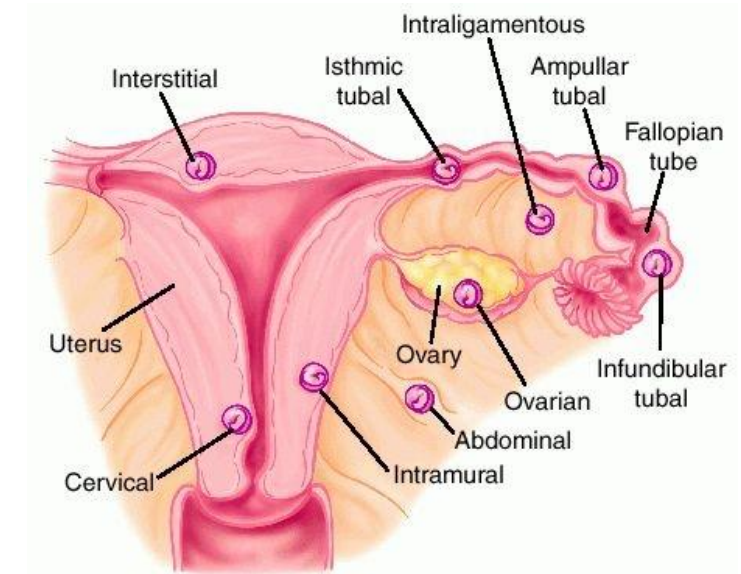
Patogenese:

Normalt:

- Ægget befrugtes i den distale del af salpinx (æggelederen)
- Transporteres til livmoderen, hvor det implanteres og begynder at udvikle sig

Implantation uden for livmoderen

- Hyppigst i salpinges
- Sjældnere tilfælde i bughulen, på ovariet, i cervix



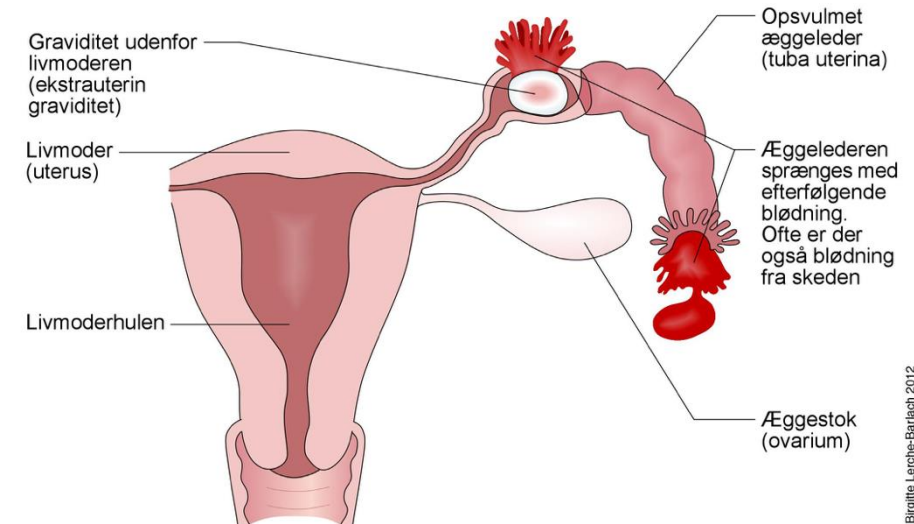
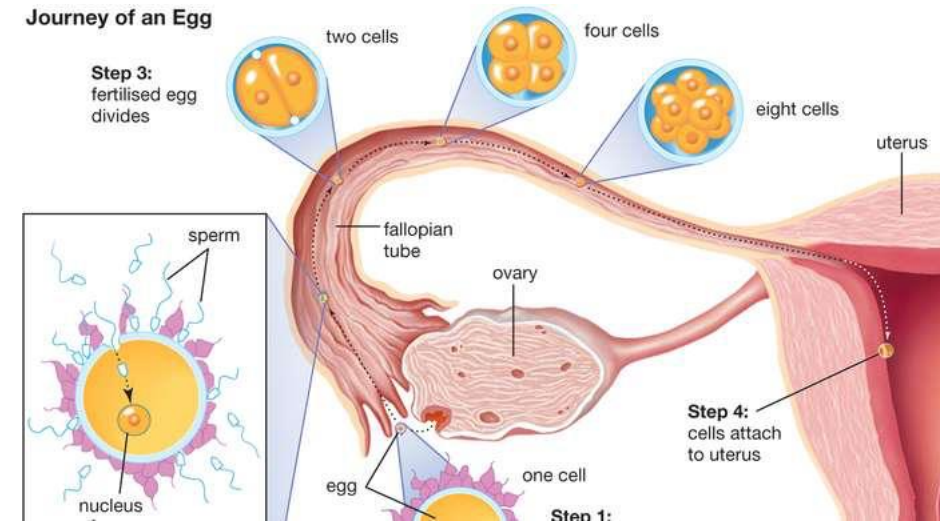
Ekstrauterin graviditet

Ætiologi:

Forstyrrelse af de normale passageforhold (fra salpinx til uterus)

- Tidligere underlivsinfektion (ofte klamydia)
- Beskadiget epitel i æggelederne – sædceller kan godt trænge igennem, men det befrugtede æg kan ikke
- Det befrugtede æg "fanges" uden for livmoderen og begynder at vokse her

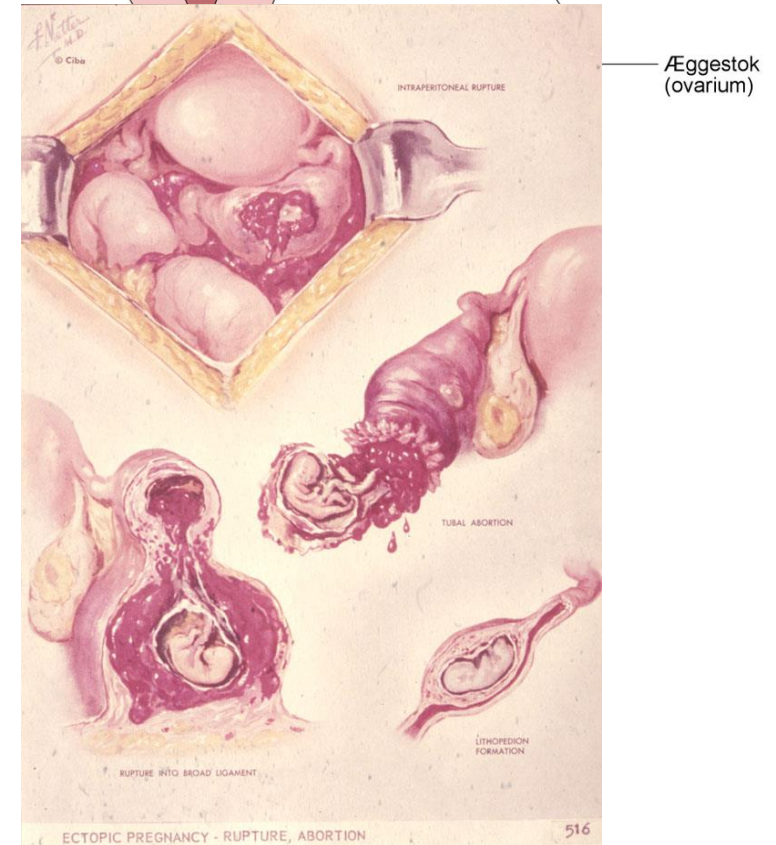
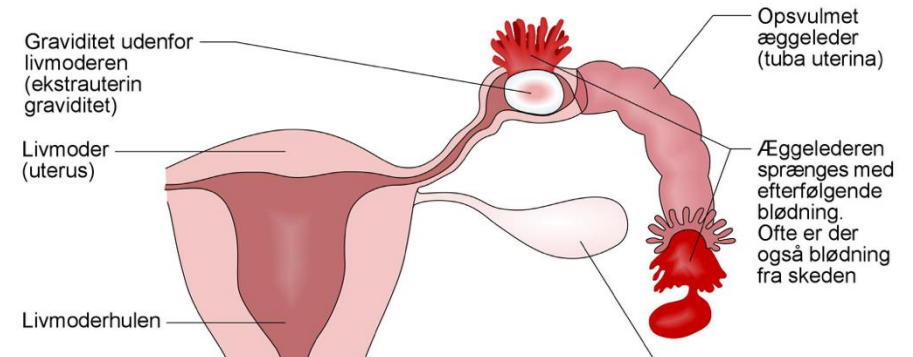
En graviditet kan ikke udvikle sig i æggelederen og går enten til grunde eller medfører, at æggelederen brister med blødning ud i bughulen



Ekstrauterin graviditet

Symptomer og fund:

- Kan variere fra let ukarakteristisk ømhed i maven til en akut påvirket patient med blødningsshock
- Rumperet/sprunget graviditet uden for livmoderen
 - Bleg
 - Klamsvedende
 - Lavt blodtryk
 - Høj puls
 - Bugvæggen er øm og hård (peritoneal reaktion)
 - Evt. bughule fyldt af flere liter blod
- Vaginalblødning
 - Endometriet stimuleres af graviditet (uanset lokalisation)
 - Ofte ustabilt med tendens til blødning



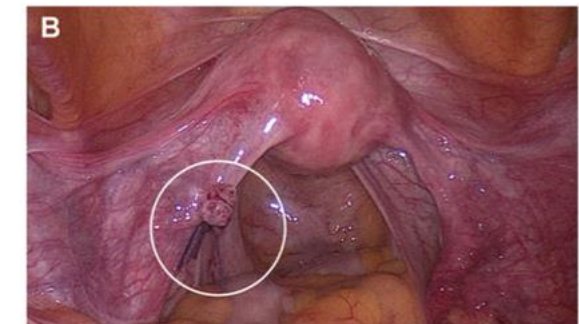
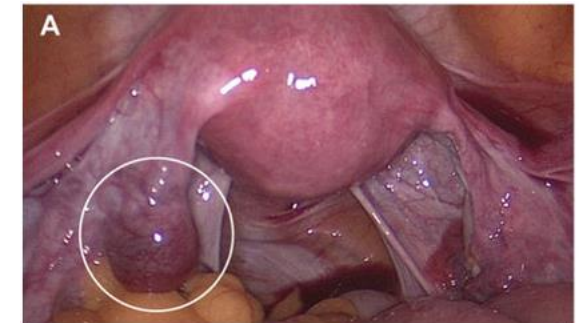
Ekstrauterin graviditet

Diagnostik:

- Kan somme tider ses ved ultralydsscanning
- Ellers skal tilstanden mistænkes ud fra
 - Anamnese med karakteristiske symptomer
 - Manglende synlig graviditet i livmoderen + positiv graviditetstest
- Evt. kikkertundersøgelse af bughulen ved uoverenstemmelse mellem hCG konc. og fund ved scanning

Behandling:

- Svære tilfælde: Væske + blod + akut operation
 - Er æggelederen ødelagt, fjernes den
- Mindre akutte tilfælde: Fjernelse af graviditeten
 - Hvor graviditeten er lille, og æggelederen ikke er ødelagt
 - Håbe at passagen gennem æggelederen er intakt
- Alternativt: Mild kemoterapi, da trofoblastvæv (graviditetsvæv) er meget følsomt for cellegift



Opgave 5

Eksamensopgave sommer 2020 syge-reeksamen

I sidste halvdel af graviditeten kan der hos moderen opstå en potentielt livstruende tilstand karakteriseret ved hypertension og proteinuri

- Angiv navn og definition for denne tilstand
- Redegør for patogenese (sygdomsudvikling) og ætiologi (årsag), symptomer, fund og følgetilstande (for både moder og barn)

Præeklampsi (svangerskabsforgiftning)

Definition:

En tilstand efter 20. graviditetsuge med

- Proteinuri (proteinudskillelse i urinen)
- Hypertension
 - $BT > 140/90 \rightarrow$ let præeklampsi
 - $BT > 160/110 \rightarrow$ svær præeklampsi
- Forekommer i 1-2% af alle graviditeter
- Optræder ofte hos førstegangsfødende og forsvinder efter fødslen



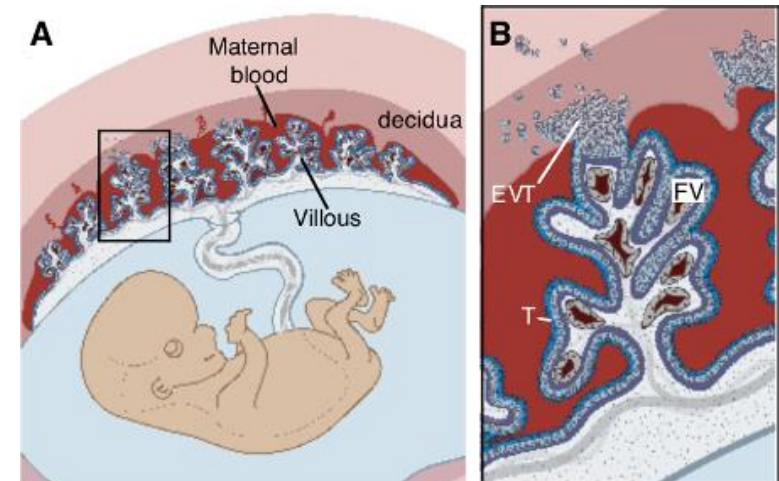
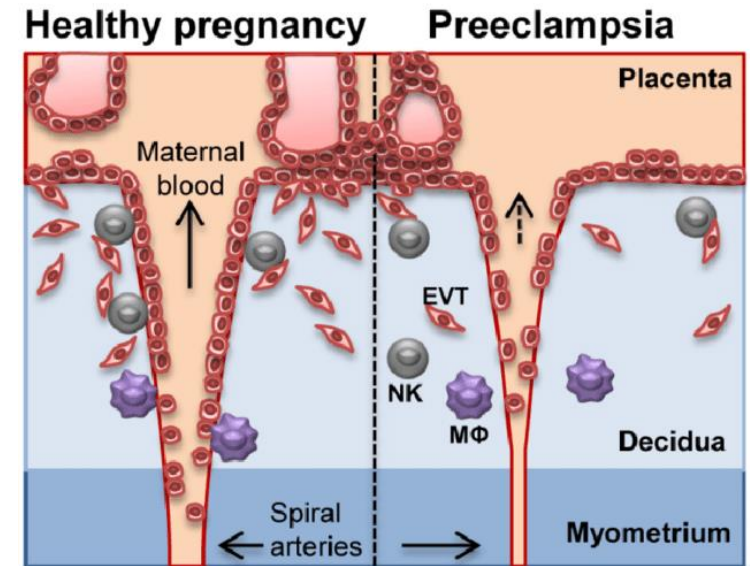
Præeklampsi

Patogenese:

- Skyldes **øget modstand i blodkarrene** i placenta (moderkagen) og moderens kredsløb
- Blodgennemstrømning og funktionen af placenta nedsættes
- Blodgennemstrømningen af moderens organer nedsættes, og blodtrykket stiger
- Nedsat blodgennemstrømning i nyrerne
 - proteinudskillelse
 - lavt plasmavolumen
 - høj hæmoglobinkoncentration
- Lav albumin i blodet → ophobning af væske i vævet → ødemer

Ætiologi

- Ukendt mekanisme, der udløser øget karmodstand
- Risikofaktorer: Diabetes, hypertension, adipositas, flerfoldsgraviditet, autoimmune sygdomme hos moder
- Ses især ved 1. graviditet og graviditet med ny partner (immunologiske forhold?)



Præeklampsi

Symptomer:

- Hovedpine
- Svimmelhed
- Synsforstyrrelser
- Kvalme
- Mavesmerter opadtil
- Trykken for brystet

Fund:

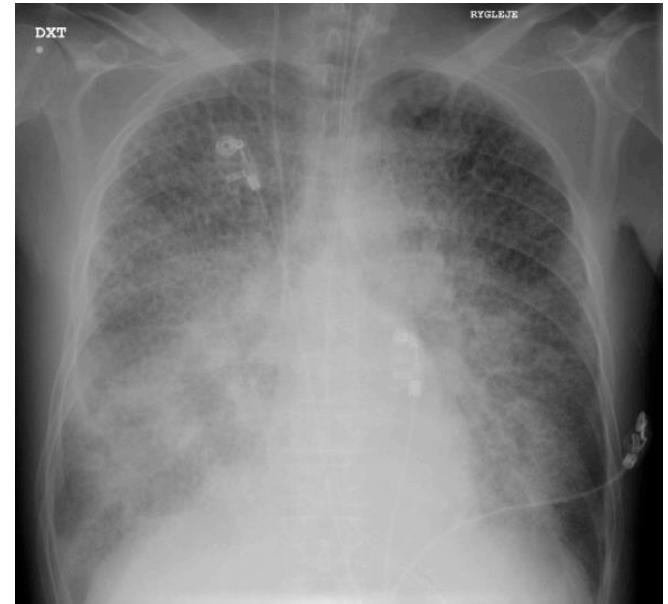
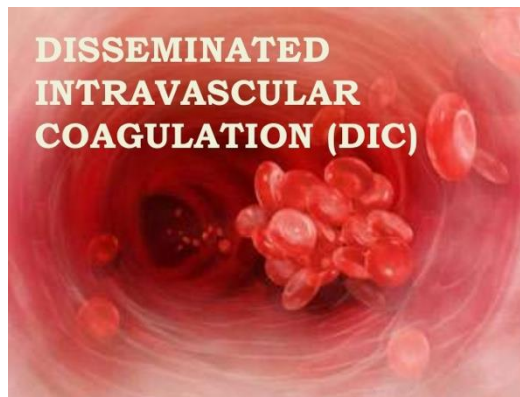
- Forhøjet blodtryk
- Hurtig vægtøgning og ødemer
- Opkastninger
- Proteinuri
- Påvirkede blodprøver (ændrede koagulationsevne, leverfunktion, nyrefunktion, væskebalance)
- Påvirket almentilstand (i svære tilfælde)



Præeklampsi

Følgetilstande:

- Væksthæmning af fosteret (pga. dårligt fungerende placenta)
- Eklampsi (fødekramper) – generaliseret krampeanfald der opstår før, under eller efter fødslen
- Hjerneødem (og derved evt. bevidstløshed)
- Lungeødem
- Aftagende nyrefunktion
- Leverpåvirkning (+ øget blødningstendens)
- Dissemineret intravaskulær koagulation (DIC)



Do you remember?

En upåvirket patient med spontant abort behandles primært med

1. PPI
2. Progesteron
3. Pantaprazol
4. Prostaglandiner

En ekstrauterin graviditet er hyppigst lokaliseret i

1. Salpinx
2. Abdomen
3. Ovariet
4. Cervix

En gravid patient med proteinuri og et BT på 145/92 har

1. Let præeklamsi
2. Svær præeklamsi
3. Ingen problemer

Ud af alle graviditeter forekommer ekstrauterin graviditet hos

1. 1-2 %
2. 3-5%
3. 10%
4. 12-14%

Præeklamsi skyldes primært

1. Voldsomt blodtab hos moderen
2. Forhøjet hjerterefrekvens
3. Øget modstand i blodkarrene

Tak for i dag 😊

Vi ses til "Infektionssygdomme" og
"Kræftsygdomme" i næste uge

I er altid velkomne til at skrive til mig, hvis I har spørgsmål

Mail: louise.heindal@sund.ku.dk